

07 - 01- Reflux gastro-oesophagien (RGO) - Pr. Oubaha

On commence notre cours de pathologie digestive par le cours de reflux gastro-oesophagien. Le reflux gastro-oesophagien est une pathologie très fréquente. Ainsi, pour notre cours, nous allons nous fixer des objectifs pédagogiques suivants.

Tout d'abord, on doit connaître comment survient ce reflux gastro-oesophagien et par conséquent, on doit connaître les mécanismes physiopathologiques du reflux gastro-oesophagien. Par la suite, on doit être capable de mener une démarche diagnostique pour proposer une prise en charge thérapeutique et bien sûr, l'étudiant doit être capable de surveiller cette pathologie afin de rechercher les complications. En guise d'introduction, pour définir ce reflux gastro-oesophagien, on va le définir comme étant le passage d'une partie du contenu gastrique vers l'oesophage mais cette pathologie n'est considérée comme pathologique que quand elle est responsable de symptômes et ou de lésions oesophagiennes.

Cela veut tout simplement dire qu'il y a une partie de reflux physiologique qui, elle, n'entraîne ni symptômes ni lésions. Mais quand ce reflux est responsable de symptômes et ou de lésions, c'est le reflux gastro-oesophagien pathologique et qui est considéré comme une maladie de l'appareil digestive. C'est une pathologie qui est connue pour avoir une évolution au long cours qui est le plus souvent bénigne mais en fonction de certaines conditions et comme vous le remarquez, je l'ai mis en rouge ces conditions puisque tout simplement, ce reflux peut se compliquer en l'absence de ce diagnostic précoce et de traitement correct.

Donc il peut se compliquer. Ces complications peuvent aller de l'oesophagite peptique qui a une gravité variable à la sténose, à l'hémorragie et même au cancer en passant par l'étape pré-néoplasique représentée par l'ondobranchiosophage. Cette pathologie a connu de grandes améliorations quant à sa prise en charge essentiellement grâce à la meilleure compréhension physiopathologique ce qui a permis de développer des investigations performantes pour poser le diagnostic et de proposer des thérapeutiques qui sont beaucoup plus efficaces qu'auparavant.

Tout d'abord, on commence par un bref rappel anatomophysiologique. Comme vous le savez, l'oesophage est ce conduit musculo-membraneux qui part de la région oropharyngée jusqu'à l'estomac. C'est un conduit qui fait environ 25 cm de long qui a un diamètre de 2 cm quand il est vide.

C'est essentiellement un conduit qui est constitué de musculature et de muqueuse mais il est surtout un organe qui est très profond et par conséquent inaccessible à l'examen clinique. C'est un organe également qui va traverser plusieurs zones anatomiques à savoir la région cervicale, la région thoracique, traverser le diaphragme avant de se terminer dans la cavité abdominale au niveau de l'estomac. D'un point de vue physiologique, le rôle principal de cet oesophage est donc d'amener les aliments mastiqués, déglutis et donc de les amener de la région buccopharyngée vers l'estomac.

Ceci est assuré grâce à sa capacité à avoir deux types de mouvements. Tout d'abord les mouvements péristaltiques primaires qui sont un péristaltisme qui lui est déclenché par la déglutition et donc qui va permettre de propulser ses aliments. Il y a également ce qu'on appelle le péristaltisme secondaire qui vient aider le péristaltisme primaire quand le bol alimentaire est trop volumineux et n'a pas été acheminé par ce péristaltisme primaire.

Ce péristaltisme secondaire qui lui est déclenché par une distension a également un rôle très important dans le nettoyage et la lubrification de cet oesophage. L'autre partie qui est très importante d'un point de vue physiologique c'est cette zone de jonction entre l'oesophage et l'estomac qui va permettre de constituer une limite entre une muqueuse oesophagienne qui ne tolère qu'un pH aux alentours de 6,7 et une lumière gastrique où le pH peut atteindre les 1,2. Du coup, cette différence de constitution muqueuse qui fait qu'elle peut ou non tolérer des pH très variables nécessite l'existence d'une sorte de barrière entre ces deux zones-là.

C'est une barrière qui est constituée par tout d'abord le principal élément étant le sphincter inférieur de l'oesophage. Mais ce sphincter inférieur de l'oesophage est aidé pour assurer ce rôle de barrière par un ensemble d'éléments extrasphinctériens représentés par l'angle de His, les piliers du diaphragme et le segment intra-abdominal de l'oesophage qui est soumis à une pression différente de la pression qui règne en intra-thoracique. Du coup, cette différence de pression entre la zone thoracique et la zone abdominale aide également à la fermeture de cette barrière anti-reflux.

Cette jonction oeso-gastrique est essentiellement représentative d'une barrière anti-reflux puisqu'elle permet d'éviter que le contenu acide gastrique remonte dans un oesophage dont la muqueuse n'est pas faite pour tolérer un pH aussi bas et aussi acide. Alors, pour la physiopathologie, la physiopathologie est multifactorielle. Cette pathologie n'est pas reliée à une seule anomalie.

En fait, il y a une association de plusieurs mécanismes. Ces mécanismes vont faire qu'il y a un déséquilibre entre les facteurs qui protègent la muqueuse oesophagienne et ceux qui vont favoriser son agression. Alors, le point principal, il est représenté par cette défaillance de la barrière anti-reflux.

Donc, il faut, pour qu'on ait une maladie reflux gastro-oesophagien, il faut obligatoirement avoir une défaillance de cette barrière anti-reflux. Mais ce n'est pas un facteur suffisant. La défaillance de la barrière anti-reflux est un facteur essentiel, nécessaire au développement du RGO, mais il n'est pas suffisant.

Pour qu'on ait la maladie RGO, il faut avoir la défaillance de la barrière anti-reflux, en plus d'autres facteurs physiopathologiques, représentés par l'agressivité du liquide du reflux, par l'hypersensibilité de la muqueuse oesophagienne, par un ralentissement de la vidange gastrique, par l'altération de la clairance oesophagienne, et par la défaillance de la résistance de la

muqueuse oesophagienne. Tous ces éléments, quand ils vont être présents, en plus de cette défaillance de la barrière anti-reflux, la personne va développer un reflux gastro-oesophagien maladie. Donc si on voit élément par élément, comme j'ai dit, le principal élément physiopathologique ou l'élément clé, c'est la défaillance de la barrière anti-reflux, qui est un élément nécessaire au développement du RGO.

Cette défaillance de la barrière peut être secondaire à un dysfonctionnement du sphincter inférieur de l'oesophage, comme par exemple les gens qui ont une hypotonie qu'elle soit permanente ou transitoire, mais c'est également des personnes qui peuvent avoir une hyperpression intra-abdominale, qui va faire que la pression va augmenter et va donc dépasser la pression de fermeture de ces sphincters inférieurs de l'oesophage. De toute façon, plusieurs éléments peuvent donner cette défaillance de la barrière anti-reflux. Parmi ces éléments, on a ce qu'on appelle l'hernie.

L'hernie, c'est une malposition du sphincter supérieur de l'oesophage et donc on va avoir soit qu'une partie de la muqueuse gastrique va remonter à travers le diaphragme et va remonter dans le thorax et du coup on va avoir un glissement de la muqueuse, de la lumière gastrique dans le thorax et ça va donner une hernie par glissement et c'est celle-là qui est incriminée dans le reflux gastro-oesophagien. On peut aussi avoir un autre type d'hernie qu'on appelle des hernies par roulement et vous imaginez que là, les personnes ont beaucoup moins de risque de développer une maladie reflux gastro-oesophagien et il y a les personnes qui ont les deux, aussi bien par glissement que par roulement et là aussi, puisqu'il y a une malposition. Les autres facteurs qui vont aider à renforcer cette barrière anti-reflux n'existent plus.

Du coup, ce type d'hernie favorise également la survenue de maladies reflux gastro-oesophagien. Alors, comme j'ai dit, la défaillance de la barrière anti-reflux et donc, parmi les mécanismes de défaillance, la hernie sont des conditions qui vont être nécessaires mais qui ne sont pas suffisantes pour le développement du reflux gastro-oesophagien et en particulier, quand on parle de la hernie, vous avez vu qu'il y a plusieurs types donc ce n'est ni nécessaire ni suffisant pour avoir un reflux gastro-oesophagien. Alors, l'autre mécanisme physiopathologique dont on va avoir, en plus de la défaillance de la barrière anti-reflux, on peut avoir les altérations de l'acclairement oesophagien et ces altérations de l'acclairement oesophagien sont essentiellement dues aux anomalies de la motricité oesophagienne.

Il y a d'abord des anomalies du péristaltisme primaire qui vont être responsables d'une difficulté à propulser les aliments mais c'est surtout les anomalies du péristaltisme secondaire qui interviennent dans le nettoyage et l'acclairement de l'oesophage qui seront responsables et qui seront comme facteurs physiopathologiques intervenant dans le RGO. L'agressivité du liquide de reflux. Donc, on a la condition nécessaire qui est la défaillance de la barrière anti-reflux.

A cette condition nécessaire vont se rajouter d'autres conditions comme l'altération de l'acclairement oesophagien mais également l'agressivité du liquide de reflux. Ce qui est le plus

connu, c'est un liquide acide qui vient de l'estomac qui va être très agressif mais il faut aussi dire qu'également la pepsine qui est sécrétée par l'estomac peut être responsable de lésions et peut être responsable d'un liquide agressif pour la muqueuse oesophagienne et il ne faut pas oublier que le reflux alcalin qui lui revient suite à un reflux du liquide biliaire donc un reflux duodénogastrique puis gastro-oesophagien et là, il est beaucoup plus agressif mais heureusement, il est beaucoup plus rare que le reflux acide. Le ralentissement de la vidange gastrique intervient également dans les mécanismes physiopathologiques puisqu'il va faire, quand on a un estomac dans la vidange et retardé ça va d'une part augmenter la pression à l'intérieur de l'estomac et qui peut vaincre de façon plus aisée la barrière anti-reflux mais ça va également favoriser l'existence d'un liquide disponible à refluer et du coup, cette augmentation, cette hyper-pression et ce liquide qui est disponible à refluer vont faire que le ralentissement de la vidange gastrique est également un facteur physiopathologique pour développer le reflux gastro-oesophagien maladie.

Alors, l'oesophage, il a ses propres moyens pour se protéger mais quand il y a une défaillance des résistances de la muqueuse oesophagienne ça va entraîner une hypersensibilité muqueuse oesophagienne et du coup, ces deux éléments vont entraîner en plus de l'agressivité du liquide de reflux en plus de la défaillance de la clairance et de la capacité de cet oesophage à se nettoyer et en présence d'une défaillance de la barrière anti-reflux vont faire que la personne peut développer des lésions responsables de symptômes suite à un reflux gastro-oesophagien ce qui définit le reflux gastro-oesophagien maladie. Donc, l'association de ces différents facteurs vont faire que plus la personne dans la muqueuse oesophagienne est exposée à l'acidité plus la personne a une hypersensibilité de sa muqueuse oesophagienne ça va donner les lésions, ça va donner les symptômes donc c'est surtout ces deux facteurs qui vont donner l'apparition des lésions et des symptômes lors du reflux gastro-oesophagien maladie. Donc comme on a dit, ça c'est juste pour récapituler ce qu'on a dit tout au départ que c'est un ensemble de facteurs favorisant la survenue du reflux gastro-oesophagien qui vont entraîner une défaillance entre les facteurs qui protègent et les facteurs qui agressent et qui vont entraîner le reflux gastro-oesophagien maladie.

Donc cette plaque va rassembler tous les facteurs provocants et les facteurs protecteurs qui vont favoriser l'apparition du reflux gastro-oesophagien. Alors, la grande question c'est l'hélicobactère pylori et là c'est juste à titre d'information puisque plusieurs études ont montré que l'hélicobactère pylori, donc cette bactérie qui a un rôle primordial dans un grand nombre de pathologies et en particulier de pathologies gastro-duodénales dans la maladie ulcéreuse, dans les lymphomes, dans certains cancers. Donc ça a été étudié, est-ce que cet hélicobactère pylori a un rôle dans le développement du reflux gastro-oesophagien.

Donc là, les études ont montré qu'il n'y a pas de corrélation entre la sévérité du reflux et l'infection à l'hélicobactère pylori. Donc maintenant c'est vrai qu'à chaque fois qu'on découvre et qu'on détecte l'existence de l'hélicobactère pylori suite à une endoscopie, il faut éradiquer parce que ça

peut être cause de développer d'autres pathologies, notamment la maladie ulcéreuse et les cancers. Mais il faut dire que l'intervention ou le rôle physiopathologique de l'hélicobactère pylori dans la maladie RGO n'est pas vraiment établi d'un point de vue physiopathologique.

Alors, comme on a dit au départ, le reflux est une pathologie très fréquente. Mais il faut savoir que la prévalence réelle reste très difficile à définir, tout simplement parce que les symptômes sont très variables. Donc quand on a étudié la prévalence en étudiant les symptômes qui est le mieux caractérisé qui est le pyrosis, on a trouvé qu'en pratique ça peut aller jusqu'à 30 à 50% de la population.

Les personnes qui ont une oesophagite, ça peut aller de 30 à 40% des patients symptomatiques. Donc c'est une pathologie fréquente, mais la prévalence réelle reste difficile à définir. C'est une pathologie qui peut se compliquer, et les complications et en particulier l'endobrachiosophage qui reste le lit du cancer de l'oesophage, est quand même peut atteindre 10 à 15% des patients qui sont atteints de symptômes de RGO chroniques.

Il faut savoir que le reflux augmente avec l'âge, de même que les risques de complications, plus l'âge est avancé, plus le RGO risque de se compliquer. Maintenant, comment on va faire pour poser le diagnostic du reflux gastro-oesophagien ? Et c'est notre démarche diagnostique. La démarche diagnostique, c'est tout d'abord les circonstances de découverte.

Quand est-ce qu'on sera amené à poser le diagnostic du RGO ? Le diagnostic du RGO peut être posé soit devant des symptômes digestifs typiques du RGO, soit devant des symptômes extra-digestifs, soit devant des signes malheureusement de complications. Les symptômes digestifs typiques du RGO non compliqués, c'est tout d'abord le maître symptôme, c'est le pyrosis, qui se définit d'un point de vue sémiologique comme étant une brûlure rétrosternale ascendante, un point de départ épigastrique. Ce pyrosis est lié à la remontée d'un liquide gastrique de nature acide et qui va agresser la muqueuse oesophagienne.

Le deuxième symptôme digestif typique, c'est les régurgitations acides. Ces régurgitations sont définies, là aussi, comme étant des remontées du contenu gastrique acide jusqu'au niveau pharyngé et ça survient sans effort de vomissement et sans nausée, ce qui permet de les distinguer des vomissements. Pyrosis et régurgitation sont les symptômes dont l'association est quasi-pathognomonique du reflux gastro-oesophagien.

Une personne qui vous dit que j'ai un pyrosis et qu'il y a des remontées acides sans effort de vomissement et sans nausée, c'est pratiquement pathognomonique du reflux gastro-oesophagien. L'autre caractéristique principale de ces symptômes, c'est le caractère postural, c'est-à-dire que ces symptômes du reflux et en particulier le pyrosis et les régurgitations, ils vont être aggravés par la position entéfléchie et on parle du signe du lacet et donc également ça va être aggravé quand le patient est en décubitus, surtout le soir. Ce caractère postural est également un signe principal et un élément supplémentaire qui est très évocateur du reflux

gastro-oesophagien.

En plus de ces symptômes digestifs typiques, il y a les symptômes extra-digestifs du RGO et là c'est des symptômes qui sont très variables et très déroutants vu qu'ils peuvent poser des problèmes de diagnostic différentiel. C'est essentiellement des symptômes qui peuvent être pulmonaires, ORL et même évoquant une pathologie cardiaque. Donc ça peut aller des accès de toux, une dyspnée asthmatiforme, un enroulement de la voix, des désysthésies buccopharyngées, des autalgies inexplicables, une laryngite postérieure et parfois des douleurs précordiales qui peuvent simuler un engorgement.

Mais dans ce cas ça nécessite un bilan cardiologique initial avant de dire que c'est un RGO. Donc le bilan cardiologique doit être négatif. Il y a aussi la fréquence très importante des gingivites et des caries dentaires chez les patients reflueurs et parfois les patients ont des troubles du sommeil avec des micro-éveils nocturnes qui sont secondaires à ces reflux.

Alors ces manifestations peuvent être associées à des signes digestifs du RGO mais elles peuvent être isolées. Donc ces signes extra digestifs peuvent être isolés. Et dans ce cas il faut savoir évoquer le reflux.

Mais après avoir fait un bilan pulmonaire, un bilan ORL et un bilan cardiologique en fonction du symptôme, donc un bilan approfondi qui doivent être normaux avant d'évoquer le RGO. Ceci dit, le lien de cause à effet reste très difficile à établir et nécessite des explorations plus poussées quand les manifestations extra digestives sont isolées. Toujours pour les signes qui peuvent faire poser le diagnostic du RGO, c'est les signes d'alarme.

Et là ça évoque un RGO qui est déjà compliqué. Donc c'est parfois des patients qui vont venir consulter pour une dysphagie, c'est-à-dire une difficulté à avaler. Et ça peut se voir dans un RGO compliqué de sténose peptique comme ça peut se voir dans un RGO qui est déjà compliqué de cancer de l'oesophage qui bloque le passage et donc le patient a cette dysphagie.

Le patient peut aussi consulter devant une odinophagie. Et l'odinophagie est définie comme étant une douleur rétrosternale au passage du bol alimentaire. Ce n'est pas la même chose qu'un pyrosis.

Là c'est une douleur et ce n'est pas la même chose qu'une dysphagie. La dysphagie c'est un blocage et l'odinophagie c'est une douleur rétrosternale au passage du bol alimentaire sans qu'il y ait de blocage. Là aussi c'est un signe de gravité et qui peut indiquer une complication.

Le patient peut consulter à l'occasion d'hémorragie digestive qu'elle soit extériorisée sous forme d'hématémèse, sous forme de méléna ou qu'elle ne soit pas extériorisée. Le patient peut avoir un syndrome anémique suite à ce saignement occulte. Alors au total, un RGO peut être évoqué devant des symptômes typiques qui sont le pyrosis et les régurgitations.

Il peut aussi être évoqué devant des symptômes atypiques qui peuvent être digestives ou extra-digestives. Et il peut enfin être évoqué devant des signes d'alarme qui, eux, peuvent évoquer un RGO déjà compliqué. Quelles que soient les conditions ou quelles que soient les circonstances dans lesquelles on pense et on évoque un RGO, notre examen clinique doit être systématique et complet comportant un interrogatoire bien détaillé pour rechercher l'ancienneté des symptômes, pour rechercher le type et le caractère évolutif de ces symptômes et pour rechercher les signes d'alarme, bien sûr avec un examen général complet, même s'il est souvent pauvre, lors d'un RGO non compliqué.

Alors, au terme de cet interrogatoire et de cet examen clinique, si on est devant un patient de moins de 45 ans qui a des signes digestifs typiques, donc le pyrosis et les régurgitations, qui n'a pas de signes d'alarme, c'est-à-dire qui n'a ni altération de l'état général, ni dysphagie, ni anémie, ni hémorragie digestive, ni audinophagie, là, on n'a besoin d'aucun examen complémentaire et on peut retenir à l'étape examen clinique et interrogatoire le diagnostic du reflux gastro-œsophagien et commencer un traitement. Dans les autres cas, c'est-à-dire les patients de plus de 45 ans, c'est-à-dire les patients avec les signes atypiques et les patients avec les signes de complication et les patients qui ont des signes d'alarme, là, on a besoin de faire des examens complémentaires. Et les examens complémentaires sont essentiellement représentés tout d'abord par des examens morphologiques et à leur tête, c'est l'endoscopie zoogastro-dodénale qui est la seule exploration morphologique utile, mais il faut savoir qu'elle peut être normale jusqu'à 50% des patients en montrant un oesophage d'aspect normal et dans ce cas, ça ne permet pas d'écarter le diagnostic du RGO.

Cette endoscopie zoogastro-dodénale, comme j'ai dit, c'est l'examen de première intention. Elle est indiquée quand on a des signes d'alarme, quel que soit l'âge. Elle est indiquée chez les patients qui ont un reflux et qui sont âgés de plus de 45-50 ans.

Elle est également indiquée chez les patients qui sont résistants à un traitement initial ou qui rechutent de façon précoce à l'arrêt du traitement. Elle est indiquée chez les patients qui ont des symptômes atypiques isolés. Cette endoscopie permet d'affirmer le diagnostic quand elle met en évidence l'existence d'une oesophagite.

Elle permet de dépister les complications, notamment les lésions précancéreuses représentées par l'oesophage de Barrett ou endobrachie oesophage. Et cette endoscopie digestive haute, il faut savoir que même si elle peut être normale, on ne peut pas écarter le diagnostic de reflux si l'endoscopie est normale. Puisqu'on peut avoir ces différents aspects.

Ça, c'est l'aspect d'un oesophage normal. Ça, c'est le cardia avec la lignée de séparation entre la muqueuse gastrique et la muqueuse oesophagienne, qu'on appelle la ligne Z. Ça, c'est un oesophage où il y a des ulcérations longitudinales et qui est également sténosée et donc rétrécie. Et là, c'est l'aspect d'oesophagite ulcérée avec une sténose oesophagienne.

Ces oesophagites peuvent être classés. Et là, on parle de la classification de SAVARI, qui va permettre de classer l'aspect qu'on voit à l'endoscopie d'une muqueuse normale jusqu'à les différents types, donc les sténoses, les ulcérations très profondes et carrément l'endobrachie oesophage. Et parfois même, on va trouver ces lésions irrégulières de cette ligne Z. La deuxième exploration morphologique qui était utilisée, c'est le transit barité.

Mais il faut savoir qu'il n'a aucune place pour le diagnostic de reflux gastro-oesophagien. On peut le demander dans certaines sténoses peptiques, mais il faut savoir que pour le diagnostic positif du reflux, le transit n'a pas de place. Les explorations fonctionnelles, à leur tête, on a la PH métrie, c'est l'exploration fonctionnelle la plus sensible pour diagnostiquer un reflux gastro-oesophagien pathologique puisqu'elle va permettre de quantifier l'exposition acide dans l'oesophage, elle va permettre d'analyser la relation temporelle entre les symptômes et l'épisode de reflux grâce aux marqueurs d'événement et elle va bien sûr permettre de relier les symptômes aux épisodes de reflux.

Elle est surtout proposée quand l'endoscopie ne montre pas d'anomalie de mycose oesophagienne. Vous vous rappelez, des 30 à 50% des patients chez qui on fait une endoscopie et on trouve une mycose oesophagienne normale, si là on a vraiment besoin d'être sûr que les symptômes sont liés au RGO, c'est cette PH métrie qui va vraiment nous aider pour dire qu'effectivement ces patients sont des reflueurs. Chez les patients qui ont des manifestations extra-digestives compatibles avec un RGO en l'absence de signes digestifs, la PH métrie a également une place importante bien sûr après les explorations cardiopulmonaires.

Elle a également une place en cas de persistance des symptômes oesophagiens gênants sous traitement antisécrétoire et elle a une indication primordiale avant une éventuelle chirurgie pour pouvoir être sûr du diagnostic avant de proposer un traitement chirurgical. Cette PH métrie, il y a deux grands types la PH métrie filaire et la PH métrie sans fil. Il y a certaines conditions pour la réaliser en particulier il faut arrêter l'utilisation des inhibiteurs de la pampoprotan pour pouvoir mesurer l'exposition acide de la mycose oesophagienne et elle est positive on dit qu'il y a un reflux gastro-oesophagien pathologique si l'exposition acide totale est supérieure à 5% du temps de l'exploration et où il y a une association des symptômes reflux qui est très importante.

On va surtout l'indiquer devant des symptômes atypiques et on va l'indiquer surtout en bilan préopérable. Donc ça c'est un exemple de tracé d'une PH métrie et on voit bien que les symptômes coïncident avec la baisse du PH. Un autre moyen d'exploration fonctionnelle c'est ce qu'on appelle l'impédance métrie et là c'est vraiment des indications très particulières relativement rares et ça c'est l'examen qui va permettre d'étudier le reflux non acide et donc c'est vraiment des patients très sélectionnés et c'est l'examen fonctionnel qui va nous permettre de poser le diagnostic d'un reflux peu ou non acide qui peut être vu dans certaines conditions.

La manométrie Campahen, c'est-à-dire la mesure des pressions, elle ne permet pas d'objectiver le reflux. Donc ce n'est pas un moyen de diagnostic positif du reflux gastro-oesophagien mais c'est

une exploration fonctionnelle qui permet d'identifier des facteurs aggravants, à savoir la défaillance de la barrière antireflux, le problème de clairance de la muqueuse oesophagienne. Elle est surtout indiquée cette manométrie dans le cadre du bilan préopératoire en cas de suspicion de trouble moteur oesophagien associé sévère et en cas de dysphagie qui est associée avec une endoscopie qui reste normale.

Donc ce n'est pas un moyen de diagnostic positif même si elle fait partie de l'arsenal des examens complémentaires mais là c'est surtout pour identifier les facteurs aggravants. Alors, comment va évoluer ce reflux ? Quand le reflux est bien diagnostiqué, il est bien traité, ça devient une pathologie de bon pronostic à condition d'avoir un bon contrôle du reflux et un suivi correct. Malheureusement, quand l'évolution se fait de façon spontanée, ça va être une évolution qui est capricieuse, chronique mais c'est surtout le danger majeur, c'est d'avoir l'oesophagite peptique à long terme et la survenue du cancer sur une dysplasie ou d'un endobrachie oesophage.

Donc l'agressivité acide peut induire des transformations progressives de la muqueuse. Ces transformations peuvent aboutir au développement des lésions ulcérées, d'un endobrachie oesophage, d'une sténose et à long terme d'un cancer de l'oesophage. C'est l'endobrachie oesophage, c'est également appelé oesophage de Barrette.

Il est défini donc par le remplacement sur une hauteur qui peut être plus ou moins grande de l'épithélium normal malpighien de l'oesophage distal par un épithélium métaplasique cylindrique de type intestinal. Donc cette métaplasie du type intestinal va être responsable d'une transformation progressive avec dysplasie et à la longue constituer le lit du cancer. Il n'y a pas de symptômes spécifiques qui vont dire que ce patient a un endobrachie oesophage ou pas.

Donc ça reste très poussé voire asymptomatique. Mais il expose au risque d'adénocarcinome puisque la métaplasie intestinale va faire qu'il y a ce risque de transformation et donc de développement d'adénocarcinome. Et quand les patients ont un adénocarcinome, le pronostic est très sombre.

La survie à 5 ans ne dépasse guère 11%. Donc la mise en évidence d'une métaplasie intestinale impose de proposer au malade une surveillance régulière avec des biopsies étagées et ceci dans le but de dépister la dysplasie qui est l'étape préalable au développement d'un cancer invasif. Donc ça c'est des images qui vont montrer d'abord ces lésions de métaplasie intestinale et donc au niveau de la ligne Z, on voit bien la différence entre cet épithélium malpighien et cet épithélium glandulaire du type intestinal.

Et donc ça c'est vraiment, c'est les zones qu'il faut surveiller et qu'il faut biopsier. Et quand on les biopsie, c'est surtout pour d'abord mettre en évidence cette métaplasie intestinale mais également pour rechercher l'existence d'une dysplasie qui elle est le lit du cancer et donc de type adénocarcinome. Donc c'est pour ça qu'on va se définir un certain nombre d'objectifs thérapeutiques pour traiter le RGO.

Il faut tout d'abord bien poser le diagnostic mais il faut avoir des objectifs thérapeutiques. Le premier c'est de soulager les symptômes. Le patient qui vient vous voir il a des symptômes, il faut le soulager.

Mais également il faut induire la cicatrisation des lésions et il faut éviter et prévenir les récives pour éviter cette évolution vers les complications. Donc pour avoir ces objectifs thérapeutiques, on a plusieurs options thérapeutiques. D'abord on peut neutraliser le contenu acide gastrique, comme ça le liquide qui va refluer sera moins acide.

On peut carrément inhiber la sécrétion acide gastrique. La même chose ça va permettre de diminuer l'agressivité du liquide qui va refluer. On peut protéger la muqueuse oesophagienne en limitant l'extension vers le haut des épisodes de reflux.

On peut stimuler la motricité oesogastrique pour accélérer la clairance et pour augmenter la clairance de l'oesophage et la vidange gastrique. On peut, selon les cas, les différentes options dont on dispose, on va les utiliser en fonction du cas de notre patient. D'abord, ce qui est toujours de mise, c'est les recommandations hygiéno-diététiques.

Ces recommandations hygiéno-diététiques, ça va permettre d'améliorer la qualité de vie et de diminuer les symptômes. Elles sont représentées par la surélévation de la tête par rapport au plan du lit, éviter les postures entraînant le reflux, donc lente inflexion vers l'avant, éviter les vêtements trop serrés pour ne pas trop augmenter la pression intra-abdominale, éviter les aliments qui vont diminuer le tonus du sphincter inférieur de l'oesophage, essentiellement représenté par le chocolat, par les graisses, par l'alcool, par la menthe, éviter la consommation de tabac et d'alcool, éviter le repas trop abondant et surtout le soir, et en cas de surcharge pondérale, il faut diminuer cette surcharge pondérale. Alors, pour soulager les symptômes intermittents, on peut utiliser ces alginates et ces antiacides, ça va également permettre de protéger la muqueuse et ça c'est juste un exemple des produits qui sont sur le marché et qui sont utilisés de façon très fréquente.

Alors, ça va permettre de soulager les symptômes, mais il faut savoir que ça ne permet pas la cicatrisation des lésions de la muqueuse. Les pro-kinétiques, ils peuvent aider à maîtriser les symptômes dyspeptiques fréquemment associés au RGO. Les traitements antisécrétoires, c'est la base du traitement.

Alors, plusieurs modalités, ils vont varier selon le type de RGO. Il faut distinguer, est-ce qu'on a un RGO avec ou sans oesophagite et le traitement initial, est-ce que c'est un traitement qu'on va utiliser de façon, dès le départ ou au contraire, c'est un traitement au long. C'est ce qui va permettre d'utiliser, donc pour les antiacides, on a les anti-H₂ et on a les inhibiteurs de la pompe à proton.

Il faut savoir que les anti-H₂ sont efficaces sur les symptômes de reflux et sur les lésions

d'oesophagite, qu'ils ne sont pas très efficaces pour prévenir les rechutes et que leurs présentations sous forme de comprimés effervescents et à demi-dose peuvent être utilisées comme traitements. Les anti-acides, les autres traitements anti-acides sont essentiellement représentés par les IPP, les inhibiteurs de la pompe à proton qui, eux, sont une efficacité bien sûr supérieure aux anti-H2 en termes de cicatrisation de la muqueuse et en termes de soulagement des symptômes. Donc, ça permet de maintenir une efficacité dans le temps et ils ont une très bonne tolérance.

Alors, comment on va prendre en charge à court terme? Quand on a des symptômes typiques et qui sont peu invalidants ou intermittents chez une personne de moins de 50 ans, en l'absence de signes d'alarme, on va donner les règles hygiénothétiques, on va les conseiller aux patients tout le temps et on va prescrire des alginates et des anti-acides sous forme de cure courte d'anti-H2 ou d'IPP à demi-dose, donc de 3 à 4 semaines. C'est ce qu'on appelle une cure courte dans le reflux. Quand on a une personne de plus de 50 ans et ou qui a des signes d'alarme et ou qui a une résistance d'emblée ou qui présente des rechutes rapides à l'arrêt du traitement, là, il faut obligatoirement d'abord être documenté, donc faire notre endoscopie pour éliminer des complications, en particulier à la recherche d'une muqueuse de barrette, d'une sténose ou carrément d'un cancer.

Et là, on va voir si le patient a une oesophagite ou il n'a pas d'oesophagite et on va prescrire notre traitement comme suite. Donc ça, quand le patient n'a pas d'oesophagite, on peut donner des antiacides, des alginates et on peut donner des IPP. Ça, c'est le traitement initial.

Les traitements en long cours, c'est les IPP à la demande, c'est-à-dire en fonction si le patient va les prendre quand il en a besoin, c'est-à-dire quand il a des symptômes. Si l'endoscopie montre l'existence d'une oesophagite, si l'oesophagite est peu sévère, c'est les IPP pendant 4 semaines. Si l'oesophagite est très sévère, c'est les IPP qui peuvent être données pendant, bien sûr, pleine dose, qui peuvent être données jusqu'à 8 semaines.

Maintenant, quand les patients qui ont un reflux avec des manifestations extra digestives qui sont prédominantes ou isolées, il faut reconnaître que les associations ne recommandent pas des traitements par des antisécrétoires, mais il faut savoir que l'utilisation et les traitements par des IPP à double dose de façon prolongée pendant au moins 3 mois dans des situations comme la toux et, bien sûr, après avoir éliminé des infections ORL et pulmonaires peut donner une certaine amélioration chez les patients. Alors, quand on a maintenant des patients qui ont un reflux qui est résistant aux inhibiteurs de la pampa protan, il faut discuter l'éventualité de reflux non-acide. Et là, c'est l'indication de faire ce qu'on appelle une impédance métrie dont on a parlé dans les moyens d'exploration.

Il faut d'abord documenter la persistance d'un reflux acide ou non-acide, si possible par une PH impédance métrie. Donc, il faut faire les deux. En cas de reflux persistant et qui est documenté, on peut augmenter la dose d'IPP et ou l'associer aux antiacides.

Et parfois, on va arriver aux indications chirurgicales et donc proposer un traitement chirurgical. C'est chez ce groupe de patients. Pour les patients qui sont déjà compliqués et en particulier de sténose peptique, là, le traitement on va donner les IPP pleine dose mais on ne peut pas traiter la sténose par les IPP.

C'est l'indication à des dilatations endoscopiques pour essayer de lever cet obstacle. Les patients qui ont un endobrachiosophage et qu'on a fait les biopsies et qu'on n'a pas trouvé de dysplasie, là, il faut traiter par des IPP. Les antisécrotoires en cours et la chirurgie anti-reflux ne préviennent pas l'apparition de dysplasie ou d'un cancer.

Chez ces patients-là, il faut savoir proposer une surveillance endoscopique et histologique malgré le traitement. La chirurgie du reflux a pour but de réaliser un montage anti-reflux et restaurer les conditions anatomiques de la barrière anti-reflux. C'est deux grandes techniques.

La fin d'opplacature complète, c'est la plus utilisée mais il y a d'autres techniques. Cette chirurgie va se discuter chez les malades qui sont très améliorés par le traitement médical mais qui vont récidiver dès son arrêt, ce qui nécessite un traitement continu en cours. On va la discuter quand ils continuent à être gênés par les régurgitations régulièrement, même sous traitement.

Les patients qui ont une volumineuse herniatale et chez les patients chez qui la persistance du reflux anormal sous traitement a été documentée notamment par une pH métrique. C'est la fin d'opplacature. Vous voyez qu'il y a une reconstitution de cette barrière anti-reflux et un renforcement de cette barrière anti-reflux.

Pour résumer, quand on voit un patient qui a des symptômes qui font évoquer le RGO, soit qu'on a un RGO typique sans signe d'alarme et que le sujet est moins de 45 ans, on n'a pas besoin de faire d'exploration et on va donner un traitement par des IPP. Dans le cas où il y a disparition des symptômes, on va laisser le patient, la condition des règles hygiéno-diététiques et le traitement médical à la demande. Chez les patients où il y a un échec du traitement, c'est le groupe de patients qui va rejoindre ceux qui ont un RGO atypique avec signe d'alarme et qui ont un âge de plus de 45 ans où l'indication de l'endoscopie digestive haute s'impose.

Quand cette endoscopie montre un oesophage pathologique, notamment les signes d'oesophagite, il faut donner un traitement médical adapté et bien sûr, soit le malade va s'améliorer et on va lui laisser le traitement médical à la demande. S'il y a un échec, on parlera de la chirurgie. Les patients qui ont un oesophage d'aspect normal, c'est ce groupe-là chez qui on va faire des explorations fonctionnelles et en particulier la PH métrie.

Cette PH métrie peut être anormale et confirmer le RGO et là, c'est le traitement médical. Comme elle peut être d'apparence normale, mais il faut savoir que le RGO reste possible mais il y a des artefacts possibles, c'est-à-dire un patient qui n'a pas arrêté ses IPP, des patients qui ont des défaillances de l'appareillage ou autre. Mais quand elle reste normale, quand on a éliminé

ces causes-là et que la PH métrique reste d'apparence normale, on va demander une manométrie et on peut dire que ce n'est pas un RGO après avoir fait toutes ces vérifications et il faut penser aux origines cardiaques ou aux troubles moteurs de l'osophage ou aux autres diagnostics.

Pour conclure, le reflux est une pathologie fréquente. La spécificité du pérosis et des régurgitations acides est telle que ces symptômes permettent cliniquement de diagnostiquer le RGO acide sans recourir à une endoscopie, en particulier chez le sujet jeune, et donc on parle de jeune quand il a moins de 45 ans. Le RGO peut être à l'origine du symptôme extra-digestif et là ça peut être déroutant et ça nécessite des explorations.

Le RGO peut également se compliquer et les complications peuvent être très sévères et peuvent aller de l'osophagite, de sévérité variable, à l'asténose, à l'endobranchiosophage qui lui est le nid du cancer puisqu'il expose un risque accru d'adénocarcinome du bas-osophage et donc elle doit être d'abord diagnostiquée mais également surveillée endoscopiquement et histologiquement.